

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5108833-18.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: CINARA ALVES FERREIRA

MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA PROVISÓRIA PARA A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA CONSULTA ONCOLÓGICA DE PACIENTE COM INDICAÇÃO DE CIRURGIA. RISCO DE MORTE. DECISÃO MANTIDA. MEDIDA DE URGÊNCIA DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, sem manifestação, arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

5108833-18.2024.4.02.5101

510015363185 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5108833-18.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: CINARA ALVES FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência, interposta em face da decisão que deferiu a tutela provisória para iniciação de tratamento oncológico.

Segue a decisão:

Trata-se de ação ajuizada sob o rito do Juizado Especial Federal por CINARA ALVES FERREIRA em face do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, UNIÃO e MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS objetivando "que os réus sejam condenados na obrigação de fornecer a IMEDIATA adoção de todas as medidas necessárias para submeter a parte autora a respectiva consulta com especialista em oncologia e tratamento que se fizer necessário (quimioterapia e/ou radioterapia), em hospitais públicos e/ou conveniados ao SUS ou, até mesmo, na ausência destes que seja realizado o procedimento, às expensas do SUS, em hospital da rede privada - sendo-lhe assegurada, ainda, a realização de todos os exames e procedimentos necessários à plena recuperação de sua saúde".

Inicial e documentos anexados ao Evento 1.

*Inicialmente, tendo em vista a declaração de hipossuficiência, o formulário socioeconômico juntado ao Evento 1 - PROC6 e o patrocínio da autora pela DPU, **defiro à parte autora o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.***

Passo à análise do pedido de tutela de urgência.

Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) estabelece, em seu artigo 294, que a tutela provisória pode ter fundamento em urgência ou evidência.

Conforme o artigo 300, do Código de Processo Civil, o juiz poderá deferir a tutela de urgência, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como não haja perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, §3º, CPC/15).

Narra a inicial, em síntese, que a autora foi diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA DO COLO DO ÚTERO (CID C53), patologia caracterizada por crescimento descontrolado de células com potencial para invasão local de estruturas vizinhas, como vagina, útero e bexiga, além de disseminação linfática e hematogênica para órgãos distantes.

E afirma que, conforme o laudo da Dra. Sabrina Chagas (CRM 52.75496-0), oncologista clínica, e os resultados dos exames anexados, a autora necessita iniciar imediatamente o tratamento, considerando que a ressonância magnética revela uma lesão expansiva centrada no colo uterino, com protrusão para o terço superior da cavidade vaginal, obliterando a região anterior do fórnice e apresentando sinais sugestivos de comprometimento parametrial à esquerda. E afirma que se o tratamento não for iniciado dentro de poucos dias, o quadro clínico da autora poderá evoluir de forma irreversível, culminando em risco iminente de óbito, dada a gravidade e a progressão acelerada da condição diagnosticada.

Afirma, ainda, que a autora se encontra na fila desde de 07/11/2024, sob Id 6063501, ou seja, que há mais de um mês está em espera no Sistema Estadual de Regulação, contudo, que o quadro é grave e não pode aguardar regulação para o tratamento.

Com efeito, por meio da Portaria nº 874 de 16 de maio de 2013, encontra-se instituída, no âmbito do SUS, a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer, que tem como objetivo a redução da mortalidade e da incapacidade causadas pela doença, preconizando toda política pública necessária e, ainda, que o tratamento aos pacientes com câncer se dará por meio de Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia e Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON/CACON).

No caso vertente, portanto, todo tratamento necessário para a doença de câncer que aflige a autora, deve ser-lhe garantido, através das Unidades credenciadas como UNACON/CACON (cf. Portaria MS nº 140, de 27 de fevereiro de 2014).

Conforme disposto no artigo 2º da Lei nº 12.732/12 "o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único".

No caso dos autos, o exame histopatológico em que foi emitido laudo que concluiu pela presença de carcinoma escamoso com suspeita de invasão estromal é datado de 24/10/2024 (Evento 1 - atestmed16).

Com efeito, a documentação acostada ao processo evidencia a gravidade do estado de saúde da autora e a urgência de início do tratamento oncológico adequado, conforme o encaminhamento realizado por médica do SUS (Evento 1 - OFIC 15 e ATESTEMED16). Confira-se:

QUAIS RISCOS DA NÃO REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO:	O MÉDICO SUBSCRITOR DESTE LAUDO ATENDEU O PACIENTE PELO SUS?
☒ RISCO DE MORTE	☒ SIM ☐ NÃO
☐ PERDA IRREVERSÍVEL DE ÓRGÃO/FUNÇÃO	HOSPITAL/CLÍNICA: <u>DOQUE</u>
☐ RISCO DE CEGUEIRA	
☐ COMPROMETIMENTO DE FUNÇÃO	

- ESPECIFICAR RISCOS DECORRENTES DA NÃO REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO:

Paciente q cancer do colo utero
q comprometimento parametrial
e urgente a avaliç qunto
a cirurgia, para
manter a doença,
que e prec e s/ tratar
nulo no q compromet
a vida da paciente.

PRAZO MÁXIMO DE ESPERA PELO ASSISTIDO SEM QUE HAJA COMPLICAÇÃO DO QUADRO OU RISCO DE ÓBITO? (Especificar quantidade):
☒ DIAS
☐ MESES
☐ ANOS

 PREFEITURA DUQUE DE CAXIAS Secretaria de Saúde		GUIA PARA REFERÊNCIA		① 312 → regular
② DA UNIDADE ③ END: HOSPITAL PRINCIPAL DUQUE DE CAXIAS Rua Manoel Lucas, s/nº - Bairro Sagar do Marfim Duque de Caxias - RJ - Tel.: 3852-6999	⑤ PARA ⑥ ESPECIALIDADE ⑦ END	cirurgia quimica (oncologica)		
④ TELEFONE	⑧ DATA ____/____/____	⑨ SALA ____	⑩ HORA ____	
⑪ NOME DO PACIENTE: <u>Leandro A. Lima</u>		⑫ Nº DE PRONTUÁRIO (ORIGEM)		
⑬ QUADRO CLÍNICO: <u>CCC colo utero.</u>				
⑭ EXAMES REALIZADOS: <u>CCC colo utero.</u>				
⑮ DIAGNÓSTICOS: <u>CC colo utero</u>				
⑯ CONDUTA: <u>cirurgia</u>				

Por meio da Portaria nº 874 de 16 de maio de 2013, encontra-se instituída, no âmbito do SUS, a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer, que tem como objetivo a redução da mortalidade e da incapacidade causadas pela doença, preconizando toda política pública necessária e, ainda, que o tratamento aos pacientes com câncer se dará por meio de Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia e Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON/CACON).

No caso vertente, portanto, todo tratamento necessário para a doença de câncer que aflige a autora, deve ser-lhe garantido, através das Unidades credenciadas como UNACON/CACON (cf. Portaria MS nº 140, de 27 de fevereiro de 2014).

Conforme disposto no artigo 2º da Lei nº 12.732/12 "o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico **ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único**".

Ante o teor da documentação ora juntada ao feito, verifico que resta comprovada nos autos a necessidade terapêutica que enseja a diminuição do prazo estabelecido no artigo 2º da Lei nº 12.732/12, em especial tendo em vista que foi asseverado em laudo emitido por médica do SUS de 03/12/2024 a necessidade de realização de avaliação urgente quanto à realização de cirurgia e, também, expressamente indicada a existência de risco de morte caso o tratamento adequado não seja iniciado no prazo de dias (Evento 1 - OFIC15).

Ademais, mesmo que não estivesse provada a necessidade terapêutica que enseja a necessidade de tratamento urgente e a redução do prazo regular de 60 dias para início de tratamento oncológico, assevero que o prazo máximo de 60 dias para início do tratamento se encerraria em 22/12/2024 e, no caso concreto, a menos de 10 dias dessa data sequer ocorreu o agendamento para primeiro atendimento oncológico.

Consoante se extrai da Constituição Federal de 1988, à Saúde foi dispensado o status de direito social fundamental (art. 6º), atrelado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, consubstanciando-se em "direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196).

Dispõe, ainda, o § 1º do art. 198 da Carta Magna que "O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes".

Outrossim, a responsabilidade do Estado (lato sensu) em relação à garantia do direito à saúde, já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que, em Sessão Plenária, afirmou o entendimento no sentido de ser possível a intervenção judicial nas políticas públicas atinentes a esse direito e definiu, após audiência pública, critérios e parâmetros para a análise das demandas de saúde, a fim de que não haja indevida interferência do Judiciário nas políticas a cargo dos demais Poderes, bem como não permaneça, por outro lado, indiferente diante de situações de graves ofensas ao direito à saúde. Estabeleceu, ademais, tratar-se de obrigação solidária repartida entre todas as esferas de governo, razão pela qual União, Estados e Municípios são legitimados passivos em demandas dessa espécie, em litisconsórcio facultativo. Nesse sentido:

EMENTA: Suspensão de Liminar. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde- SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos

entes da Federação em matéria de saúde. Ordem de regularização dos serviços prestados em hospital público. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança pública. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento. (SL 47 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-01 PP-00001)

Com relação à natureza solidária da obrigação Estatal de oferecer as prestações de saúde à população brasileira e, ainda, sobre a possibilidade de o Poder Judiciário adotar as providências cabíveis para concretização desse direito, no exercício de suas atribuições constitucionais, sem que isso implique em violação à separação de Poderes, não subsistem maiores dúvidas no estágio atual da jurisprudência pátria.

Como se observa, existe sólida e amplamente majoritária corrente jurisprudencial acolhendo a responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios nas demandas envolvendo prestações de saúde no âmbito do SUS, assim como a possibilidade de o Judiciário deliberar a respeito, quando identificado o descumprimento ou atuação estatal insuficiente, relativamente ao direito fundamental à saúde, sem que essa atuação implique em violação à separação de poderes, reserva do possível ou normas orçamentárias. Do contrário, restaria conferida ao administrador a possibilidade de fazer tábula rasa da proteção à saúde delineada pelo Constituinte.

É importante consignar que o magistrado, quando exerce seu mister em demandas referentes às políticas públicas de saúde, não o faz de forma a substituir-se ao administrador, mas sim no exercício da função constitucional que lhe foi atribuída, nas hipóteses em que é indispensável para garantir o direito à vida e à saúde, evitando, com isso, a ocorrência de graves danos a direitos fundamentais e, inclusive, a incidência de óbitos de jurisdicionados, como tem sido, inclusive, observado em algumas hipóteses, mas que talvez pudessem ser evitados pela atuação tempestiva do Poder Judiciário.

No presente caso a documentação acostada à inicial evidencia a urgência do quadro de saúde da autora e a necessidade de encaminhamento urgente da autora para tratamento oncológico adequado. Depreende-se, pois, a probabilidade do invocado direito.

O direito à vida e à saúde é o mais fundamental direito do ser humano, pois é a base, o antecedente, o pressuposto, a condição indispensável para o exercício de qualquer direito. Por isso, o direito à vida e à saúde não pode ser relegado ao possível, ao conveniente, ao oportuno, à conjuntura econômica e financeira. É direito que, em decorrência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve prevalecer sobre o mero interesse financeiro das Pessoas Jurídicas de Direito Público.

O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se também presente, visto que o indeferimento da tutela poderá comprometer, de forma irreversível, a manutenção da higidez física da autora, com risco de óbito em dias.

Pelo exposto, defiro antecipação dos efeitos da tutela para que os réus informem unidade credenciada da rede pública com disponibilidade para realizar a primeira consulta em Oncologia - Ginecologia da autora no prazo máximo de 05 (cinco) dias, bem como para iniciar o tratamento oncológico que se mostrar indicado à autora conforme avaliação que será feita pela equipe médica de Oncologia - Ginecologia responsável pelo atendimento (seja radioterapia, quimioterapia, cirurgia ou outro tratamento que se mostre indicado) no prazo de até 05 (cinco) dias da consulta realizada, fornecendo referido tratamento enquanto for necessário ao restabelecimento da saúde da autora, sob pena multa diária que fico em R\$200,00 (duzentos reais) para cada réu, limitada a R\$10.000,00 (dez mil reais) para cada réu. Intimem-se os réus para cumprimento com urgência.

Intimada, a parte recorrida não apresentou impugnação.

VOTO

A paciente recebeu prescrição de cirurgia por médico de entidade de saúde do município de Duque de Caxias (evento 1, DOC16 dos autos principais).

Sendo o diagnóstico de câncer no útero, a gravidade da doença revela a urgência do início do tratamento e realização da cirurgia ou, ao menos, de exames acurados para aferir a necessidade e conveniência desse procedimento.

Portanto, a decisão deve ser mantida, uma vez que a demora na prestação do atendimento pode implicar o agravamento do quadro clínico, quiçá a morte da paciente.

Ante o exposto, **VOTO POR NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA.** Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, sem manifestação, arquivem-se.

